

on võimalik), siis osakoormusega töötajate palkamine on ettevõttele liiga kulukas ning seetõttu on osalise ajaga tööd raske leida. Probleemi aitaks leevendada see, kui riik kaotaks esmalt minimaalse sotsiaalmaksu nõude. Oleme selle ettepaneku valitsusele ka korduvalt teinud.

Kolmanda peamise küsimusena näeme ennetavat ümberõpet. Töö kaotuse korral on kõige raskem uut tööd leida eakatel töötajatel ja palgaredeli alumises otsas kõige lihtsamat tööd tegevate väheste oskustega töötajatel. Samal ajal on ettevõtetel probleeme sellega, et vajalike oskustega töötajaid lihtsalt ei ole. Töötuks jäämist tuleb ennetada, alustades ümberõpet võimalikult vara. Üks võimalus selleks on kasutada töötukassa reserve.

Mainisin teiste probleemide kontekstis korduvalt tööjõupuudust, mis on tööandjate poolelt vaadates üks valulisemaid küsimusi. Meil on inimesi, kellel pole tööd, kuid samal ajal otsivad ettevõtted inimesi tikutulega taga nii lihtsamatele kui ka keerukamatele ametikohtadele. Ühelt poolt on see hea, sest õppida sooviv ja hakkaja inimene ei jää Eestis tööta. Teisalt takistab töökäte puudus olemasolevate ettevõtete arengut ja potentsiaalsed välisinvestorid võivad uued suurettevõtted luua mujale just seetõttu, et Eestis ei piisa töötajaid. Seetõttu on oluline tegelda nii kutse- kui ka kõrghariduse arendamisega ettevõttele vajalikus suunas, välistööjõu senisest suurema kaasamise ning töötajate ümberõppega. **S**

Töötaja tervis on töökeskkonna nägu

Mari Liis Räis, Epp Kallaste, Mart Kaska

Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR

Eestis on käimas töövõimereform, mille aluseks on mõtteviisi muutus – töövõimetuse asemel hakatakse hindama töövõimet. Sotsiaalkindlustusameti asemel hakkab töövõime hindamist korraldama töötukassa, mis rakendab mitmeid uusi meetmeid, aitamaks vähenenud töövõimega inimesi tagasi tööturule. Praegu tegeleb töövõimereform ennekõike tagajärgedega: kuidas aidata tööle inimesed, kellel töövõimekadu on juba tekkinud. Oluline on see tegevus kombineerida ennetusega ehk vaadata, kuidas mõjutab töötamine inimese tervist, et viia miinimumini töötamise negatiivsed mõjud tervisele.

Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR viis eelmisel aastal läbi uuringu

„Töötingimuste ja töökeskkonna mõju ajutise ja püsiva töövõimetuse kujunemisel ning töövõimetusega kaasnevad mõjud”. Uuringus küsitleti pikaajalise ajutise või püsiva töövõimetusega inimesi, et selgitada välja, kuidas nemad hindavad töötamise mõju oma tervisele; analüüsiti Haigekassa, Tööinspektsiooni ja Sotsiaalkindlustusameti ühendatud registriandmete põhjal ajutise ja püsiva töövõimetuse seoseid ning intervjueriti töövõimekaoga töötajate tööandjaid. Analüüs viitab varase sekkumise vajalikkusele, pakub välja konkreetse mehhanismi olemasoleva süsteemi parandamiseks ja teeb kindlaks kitsaskohad, mida on vaja ületada süsteemi toimimiseks.

Töötamine mõjutab inimese tervist mitmeti

Enamik tööealisi inimesi viibib ligi kolmandiku tööpäevast oma töökohal ning on täiesti loomulik, et töökeskkond ja tööelu mõjutavad tervist. Hästi juhitud töökeskkond, sobivad töövõtted ja vajalike kaitsevahendite olemasolu peaksid tagama selle, et inimese tervis töötamise tõttu ei halvene. Sobivate tingimuste puudumisel võib töötamine esile kutsuda haigusi.

Aga ka juhtudel, kus töötamine ja töökeskkond pole põhjustanud haiguse tekkimist otseselt, mõjutab töötamine tervist. Sageli põhjustavad haiguse töötamine või tööttingimused kombinatsioonis muude teguritega. Näiteks võib pikaajaline töötamine stressirohkel ametikohal viia südameprobleemide tekke või süvenemiseni, mille tõttu võib inimene infarkti tagajärjel kaotada osa töövõimest. Eestis ei diagnoosita selliseid juhtumeid kui tööga seotud haigusi. Infarkt ei ole kutsehaigus, aga ometi võinuks sellises olukorras parem tööaja ja koormuse korraldus säästa inimest raskest tervisekahjustusest.

Töö osatähtsust tervist mõjutava tegurina tõendab püsiva töövõimetuse ja kutse- ning tööst põhjustatud haiguste statistika. Aastal 2014 oli Eestis püsivalt töövõimetuid 91 000, seda on rohkem kui Tartu linnas elanikke. Vaid 522-l neist oli tervisehäire põhjuseks aastatel 2008–2014 diagnoositud kutsehaigus või tööst põhjustatud haigus. Uuringu raames läbi viidud küsitluse põhjal leidis aga kolmveerand vähenenud töövõimega inimestest, et just töötamine põhjustas nende haiguse või oli seotud selle ägenemisega. See viitab, et tööga, tööttingimuste ja töökeskkonnaga seotud töövõime vähenemist esineb kordades enam, kui see väljendub kutse- või tööst põhjustatud haiguste statistikas.

Seejuures on huvitav, et vähenenud töövõimega inimesed (v.a kutsehaigusest tingitud või tööst põhjustatud haigusega) ei ole teistest sagedamini kokku puutunud töökeskkonna ohuteguritega nagu sundasendid, töö ohtlike kemikaalidega jm. Küll aga töötavad vähenenud töövõimega inimesed elanikkonna keskmisega võrreldes sagedamini madala oskusmahukusega ametikohtadel. Niisiis võib arvata, et just lihttööliste töökeskkonna ja tingimuste parandamine on oluline töötamise negatiivse mõju vähendamiseks tervisele.

Ajutise töövõimetuse pikkus ennustab püsiva töövõimetuse teket, püsiv töövõimetus aga hõivest väljalangemist

Pikaajalised ajutise töövõimetuse perioodid on märgiks inimese tervise halvenemisest ning ennustavad püsivat töövõime vähenemist. Hilisematest püsivalt töövõimetutest võtab juba viis aastat enne püsiva töövõimetuse määramist haiguslehti ligi kaks korda enam inimesi kui need, kes püsivalt töövõime tuks ei jää. Samuti on hilisematel püsivalt töövõimetutel suurem haiguslehel viibitud päevade arv aastas. Samas ei erine tööhõive määr enne püsiva töövõimetuse saamist oluliselt ülejäänud elanikkonnast. Pärast püsiva töövõimetuse määramist kasvab keskmine haiguslehtede aastane kogukestus püsivalt töövõimetute seas veel mõnevõrra, samal ajal kui hõivatute osakaal langeb järsult. Püsivalt töövõimetutest inimestest töötavad Eestis umbes pooled, mis on oluliselt madalam ülejäänud rahvastiku keskmisest (pea 70%)¹.

Püsivalt töövõimetute seas on suured erinevused töövõimekao ulatuses. Mida suurem on töövõimetuse määr, seda sagedamini

¹ Uuringus analüüsitud pikaajaliselt ajutiselt töövõimetud ja võrdlusgrupp pidid olema hiljutise töötamise kogemusega, mistõttu nende gruppide hõivemäärad võivad üldpopulatsioonist erineda.

jääb inimene koduseks. Küsitlus kinnitas, et enamasti on selle taga inimese tervis. Siiski ka 100% töövõimetusega inimestest ehk inimestest, kellel töövõime ametlikult puudub, töötab 13%. See näitab, et õigete tingimuste korral on paljudel inimestel võimalik edasi töötada püsivatele terviseprobleemidele vaatamata.

Varasem sekkumine aitaks tervisekadu ära hoida

Paljud vähenenud töövõimega inimesed leiavad, et õigeaegse sekkumisega oleks olnud võimalik tervisekadu vähendada või lausa ära hoida. Ligi pooled leidsid, et varajasem ravi oleks aidanud. Umbes veerand leidis, et nad ise oleks pidanud käituma teisiti, ja teist sama palju arvas, et tööandja oleks saanud midagi ette võtta. Seega on olulise osa vähenenud töövõimega inimeste jaoks võti töökeskkonnas ja töökorralduses, millega saab vähendada tervise halvenemist.

Tööga seotud tervisekahju vähendamiseks ja ära hoidmiseks on väga oluline töötaja, tööandja ja arstide koostöö. Nii töötajad kui tööandjad vajavad juhendamist ja infot, kuidas tagada, et töötamine oleks tervisele ohutu. Meedikud vajavad infot töökeskkonna ja tingimuste kohta, et tagada adekvaatne ravi. Üks võimalik viis inimeste töövõime halvenemise peatamiseks ja tööturult väljakukkumise vähendamiseks on arsti ja tööandja ühine sekkumine töötaja pikaajalise haigestumise korral. Registriandmete andmekaevalgoritm tuvastas, et püsivalt töövõimetuks jäämise risk tõuseb märkimisväärselt, kui inimene on olnud aastas vähemalt poolteist kuud haiguslehel. Kui haiguslehtede kestus aastas ületab neli kuud, siis neist inimestest neljandik jääb aasta jooksul püsivalt töövõimetuks. Kuna on teada, et töötavate inimeste tervist mõjutavad oluliselt ka töötingimused, siis tuleks selliste juhtude tarvis kavandada

meetmed, kus lisaks arsti otsusele hinnatakse koostöös töötaja ja tööandjaga ka inimese töötingimusi, nende mõju tervisele ning töökoha kohandamise vajadust. Haiguslehed pikkusega poolteist ja neli kuud märgivad otsustavaid sekkumiskohti.

Arstidel peaks olema suurem roll töötervishoiu sidumisel töökeskkonnaga

Lisaks sellele, et töötamine on suure osa inimeste tervist halvendanud, ei ole ka paljude juba vähenenud töövõimega inimeste tänane töökeskkond kohandatud vastavaks nende tervisest tulenevatele vajadustele. Kuni kolmandik nendib, et tööandja ei ole teinud töökohal vajalikke kohandusi. Osakoormusega töötajad leiavad sagedamini, et vajalikud kohandused on tehtud. See võib viidata, et just paindlik või vähendatud tööaeg ongi see, mis on vajalik vähenenud töövõimega töötajatele.

Eestis on töötervishoiuarsti külastanud töötajate osakaal madal jäädes kahe kolmandiku juurde, ja see ei ole aastal 2015 oluliselt suurem kui 2009. aastal (Statistikaamet, Tööelu-uuring 2009 ja 2015). Eestis ei ole töötervishoiuarsti külastamine kohustuslik, kui töökoha riskianalüüsi põhjal ei ole riskid inimese tervisele kõrged. Riskidena määratletakse füüsilise töö tegijatel nt suurte raskuste tõstmine ja töö kõrgustes, kontoritöötajatel on aga üheks riskiallikaks arvutiekraan. Arsti nõuanded on seda vajalikumad, mida enam on inimesel varasemaid tervisekahjusid või eelsoodumusi.

Uuringust ilmnes, et sarnaselt muude töötajatega pole kolmandik töötavatest püsiva töövõimetusega inimestest praeguse tööandja juures töötervishoiuarsti külastanud. See tähendab, et ka tõsiste terviseprobleemidega töötajad ei saa arsti nõuandeid. Isegi juhul, kui keskmisele tervisehäireteta töötajale on

töökeskond ohutu, siis tõsisemate tervisehäirete korral võib see olla terviseriske suurendav ning inimene võib vajada spetsiifilisi kohandusi oma tervise säästmiseks. Selleks et tagada tervisest tuleneva töövõime langusega töötajate piisav informeeritus, peaksid sellised töötajad töötervishoiuarsti juurde jõudma sõltumata töökoha riskianalüüsist. Kuna sellise täiendava kohustuse seadmine tööandjale muudab terviseprobleemidega töötaja palkamise kulukamaks, on vaja riigi tuge tervisekontrolli korraldamiseks.

Tervisehäiretega inimesed puutuvad töötervishoiuarstist tõenäoliselt sagedamini kokku oma perearsti või eriarstidega. Kuigi mitte kõik, nõustab neist osa ka inimesi tööalaselt tervist hoidma. Ligi pooltele püsivalt töövõimetutest ja pikaajalistest ajutise töövõimetusega inimestest olid perearst või eriarst selgitanud, kuidas töötada tervist säästvalt. See tähendab, et paljud arstid siiski ei juhi lisaks haiguse ja sümptomite ravile inimeste tähelepanu sellele, kuidas tööelus tervist säästa. Kuna perearstid puutuvad töötavate inimestega palju sagedasemini kokku, siis tuleks nad integreerida töötervishoiu süsteemi. Pakkumata välja täpset asjakorraldust, võiks näiteks perearstil olla võimalik kontakteeruda tööandjaga või suunata töötaja töötervishoiuarsti juurde, kes tuvastaks võimalikud puudujäägid ja aitaks suunata tööandjat ning töötajat töötingimuste parandamisele.

Töötajate informeerimise kõrval on oluline pakkuda tuge ka tööandjatele töökeskonna kohandamisel ja töötingimuste kujundamisel. Uuring näitas, et üldjuhul töötervishoiuarstid töökohal ei käi ja seega neil objektiivset pilti töötingimustest pole. Samuti on töötervishoiuarstide otsused töötaja sobivuse kohta ametikohale napisõnalised ega paku üldiselt infot töötingimuste ja -keskkonna parandamiseks. Nii jääb tööandjale võimalus vabatahtlikult tellida tasulist konsultatsiooniteenust,

mis aga enamiku tööandjate jaoks on kulukas ning seda ei peeta kuigi oluliseks.

Terviseprobleemidega inimeste kaasamine ja toetamine tööturul eeldab suhtumise muutumist

Tervise hoidmine on eeskätt inimese enda vastutada, ent sageli ei soovita tööandjale oma probleeme ja vajadusi selgitada, kartes rikkuda karjäärivõimalusi. Kuigi küsitluses osalenud vähenenud töövõimega inimesed väitsid enamasti, et on tööandjat oma erivajadustest informeerinud, oskasid tööandjad tuua palju näiteid terviseprobleemide sihilikust varjamisest. Sellise käitumisega võib töötaja teha karuteene iseendale, kuna ajapikku võivad väikesed ebamugavused muutuda pöördumatuks tervisekahjustuseks ja töötamine senisel kohal osutuda võimatuks. Samuti jääb tööandjal saamata potentsiaalne kasu soodustustest, toetustest ja teenustest, mida on võimalik saada vähenenud töövõimega inimeste palkamisel.

Pikaajalise haiguse puhul on lisaks tervisest tulenevatele raskustele keeruline tööle naasta ka seetõttu, et enamasti on tööandja pidanud töötajale juba asendaja leidma. Rääkides tööturule naasmisest, lisanduvad takistustena sobiliku tööandja leidmine, uue tööandja veenmine oma oskustes ja võimetes ning vajadus ümberõppe järele. Uuringu käigus intervjueeritud tööandjate hinnangul takistab tervisehäiretega inimeste värbamist vähene teadlikkus erinevatest terviseprobleemidest ja nendega kaasnevatest erivajadustest töökohal.

Käimasoleva töövõimereformi valguses tulebki tähelepanu pöörata muuhulgas teavitustegevustele ja julgustamisele avatud suhtluseks. Kuigi tervis on paljude jaoks delikaatne küsimus, ei saa töötervishoiu jätta individuaalseid erivajadusi tähelepanuta. Tervisega seotud küsimustele peaksid julgelt